

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083393-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JOAO GABRIEL BRASIL DE PAIVA

RECORRENTE: JOSE ROBERTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA CAUTELAR - CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - DIREITO À SAÚDE - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS DE QUE CANABIDIOL ENCONTRA-SE INDICADO AO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA - ESTADO NÃO PODE SER OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 1.165.959 E RE 657.718 -MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS EM LISTA OFICIAL DE DISPENSAÇÃO DO SUS - TEMAS 6 E 1.234 DO STF - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA, ACURÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL - RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO NA ORIGEM MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR, para MANTER a decisão recorrida. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista tratar-se de simples incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, inclusive o MPF. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5083393-20.2024.4.02.5101

510015290950 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5083393-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: JOAO GABRIEL BRASIL DE PAIVA

RECORRENTE: JOSE ROBERTO CAPISTRANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo da 34ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5059943-48.2024.4.02.5101 (Evento 18), de indeferimento da tutela de urgência requerida pela parte autora, objetivando que os réus sejam compelidos solidariamente a fornecerem o produto Canabidiol – Prati-Donaduzzi (200mg/ml), para tratamento da doença que o acomete.

Sustenta a recorrente, em síntese, que os medicamentos fornecidos pelo SUS não foram eficazes e que não tem condições financeiras de arcar com o custeio do tratamento, obtendo boa resposta com o uso do Canabidiol. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com posterior provimento para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Parecer do MPF pela procedência da medida cautelar (Evento 6).

Tutela indeferida no Evento 8.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos às pessoas que não tenham condições financeiras para custear sua aquisição.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Embora haja um dever solidário dos entes federados em prover uma assistência integral à saúde, tal qual exposto anteriormente, não se ignora que uma mesma doença possa ser tratada de diversas formas e com diferentes medicamentos, sendo a definição do tratamento adequado a cada caso uma questão de ordem médica e não propriamente de ordem jurídica. Assim, a escolha da alternativa terapêutica adequada a cada doença, quando seu tratamento é feito pelo Sistema Único de Saúde, cabe em princípio ao corpo médico do sistema único de saúde, tal qual estruturado na legislação, devendo tais escolhas ser em princípio prestigiadas pelo Poder Judiciário, na medida em que embasadas em estudos técnicos na área de medicina.

No entanto, embora a escolha do administrador, com base em estudos técnicos, deva ser em princípio prestigiada, não está o Judiciário a ela absolutamente adstrito ou impedido de atuar supletivamente, caso haja nos autos indicativo de que a terapêutica oferecida não tem se mostrado adequada ou suficiente, havendo outras alternativas disponíveis. Entender de modo contrário seria retirar do Poder Judiciário a atribuição de tutelar os direitos fundamentais, em flagrante violação à Constituição.

É de salientar que, no tocante à possibilidade de fornecimento de medicamentos não constantes de listas do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do Recurso Especial 1.657.156, vinculado ao tema repetitivo 106, firmou a seguinte tese:

"4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência"

Da documentação acostada em Evento 1, Anexo 2 dos autos originários, emitida por neuropediatra assistente, extrai-se que o recorrente apresenta diagnóstico de má formação complexa (paquigiria, lisencefalia e esquizefalia) do sistema nervoso central secundária à infecção congênita por Zica Vírus, evoluindo com encefalopatia crônica não progressiva e epilepsia precoce de início no período neonatal, de difícil controle, hidrocefalia, déficit intelectual grave, disfagia, puberdade precoce, transtorno de comportamento e distúrbio do sono.

Utilizou os medicamentos Clobazam, Levetiracetam, Fenitoína e Fenobarbital, sem melhora significativa. Atualmente usa Topiramato, Lamotrigina, Depakote, Sprinkle, Risperidona e Neozine. Não há controle efetivo das crises epiléticas, sendo prescrito tratamento com Canabidiol Prati-Donaduzzi (200mg/ml).

De acordo com o parecer do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde - NAT, em Evento 15, o Canabidiol não possui registro na ANVISA e não integra nenhuma lista oficial de medicamentos. Além disso, *"Quanto à indicação do pleito, destaca-se que até o momento não há registro no Brasil medicamento de princípio ativo Canabidiol com indicação para o tratamento da epilepsia"*.

Ressalta-se em referido parecer, ainda, que *"No entanto, os cinco principais estudos que levaram à aprovação do Canabidiol no tratamento adjuvante na epilepsia apontam sua eficácia somente em pacientes com síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. A eficácia do Canabidiol em outras epilepsias farmacorresistentes ainda não está bem estudada⁵. Salienta-se que o quadro epiléptico apresentado pelo Autor, não possui origem nas supraditas condições - síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa."*

Outrossim, o STF, no RE 657718/MG, Tema 500 da repercussão geral, estabeleceu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais:

(...) 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (...)
(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020)

Não se olvida que o STF, no RE 1.165.959 (Tema 1161), em caso que envolvia o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, firmou o entendimento de que o Estado possui o dever, em termos excepcionais, de fornecer medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização para a sua importação, concedida pela própria agência, além de outros requisitos. Confira-se:

"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS".

Ocorre que, no caso em análise, não há evidências de que o fármaco pleiteado encontra-se indicado ao quadro clínico da parte autora, tratando-se, portanto, de tratamento de natureza experimental, amoldando-se mais à tese prevista no Tema 500.

No mais, em 26/09/2024, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 566471, Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, o STF fixou as seguintes teses (**Tema 6 e 1234 da repercussão geral** - RE. DJE divulgado em 27/09/2024, publicado em 30/09/2024.):

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficial aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Por fim, determinou, tal como no Tema **1.234**, que essas teses sejam transformadas em enunciado sintetizado de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação (Enunciado publicado no DJE e no DOU em 03/10/2024):

Súmula vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Ademais, no tocante à competência, foi destacado o seguinte no referido Tema 1.234:

I - Competência.

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

Destaca-se, todavia, que no tocante à competência, houve modulação dos efeitos, de modo que somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 12/08/2024, não haverá alteração da competência.

No mais, a tese do Tema 6 do STF estabelece uma regra geral: a ausência de um medicamento nas listas oficiais do SUS, em princípio, impede seu fornecimento por decisão judicial (item 1 da tese). Essa diretriz reflete uma deferência judicial às políticas públicas de saúde definidas pelo Poder Executivo, considerando que as listas são elaboradas com base em análises técnicas fundamentadas em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade, e não de forma casuística.

Todavia, o STF também definiu os parâmetros que permitem exceções a essa regra, conforme disposto no item 2 da tese:

1. A comprovação de negativa administrativa prévia;
2. A demonstração de ilegalidade ou omissão no processo de incorporação do medicamento;
3. A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS;
4. A comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento;
5. A demonstração da imprescindibilidade do tratamento;
6. A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente.

Nos termos do Tema 1.234 do STF supramencionado, deverá ainda ser analisado se o autor demonstrou a impossibilidade de substituição por outro medicamento das listas do SUS e protocolos clínicos; se o autor comprovou a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), o que não ocorreu no caso em exame, conforme já mencionado.

No caso em tela, ademais, não foi apontada ilegalidade na negativa de fornecimento e na atuação da Conitec. O parecer de processo 5059943-48.2024.4.02.5101/RJ, evento 15, PARECER1 indica o seguinte:

6. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) avaliou o **Canabidiol** no tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos, e recomendou a sua **não incorporação** pelo Sistema Único de Saúde – SUS⁷.

7. A CONITEC considerou não haver evidências suficientes para justificar a incorporação de um produto de *Cannabis* específico. Dentre os motivos, constam: grande variabilidade de apresentação dos produtos de *Cannabis*; não comprovação de intercambialidade ou equivalência entre os produtos disponíveis e os que foram utilizados nos estudos clínicos; incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de *Cannabis* para a indicação proposta⁸.

Constata-se a existência, veracidade e legitimidade dos motivos apontados no ato administrativo como fundamentos para a sua prática.

Portanto, há óbice ao pleito autoral, eis que, sem incursão no mérito do ato administrativo, não foi apontada irregularidade procedimental ou de ilegalidade na negativa na decisão da CONITEC, que apontou motivo existente, real e legítimo de acordo com os parâmetros construídos pelo STF para não incorporação do fármaco pleiteado no âmbito do SUS.

Com efeito, diante da ausência de demonstração dos requisitos necessários e excepcionais para deferimento de medicamentos pelo Poder Judiciário, tem-se pela improcedência da medida cautelar.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR**, para MANTER a decisão recorrida. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista tratar-se de simples incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, **inclusive o MPF**. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.